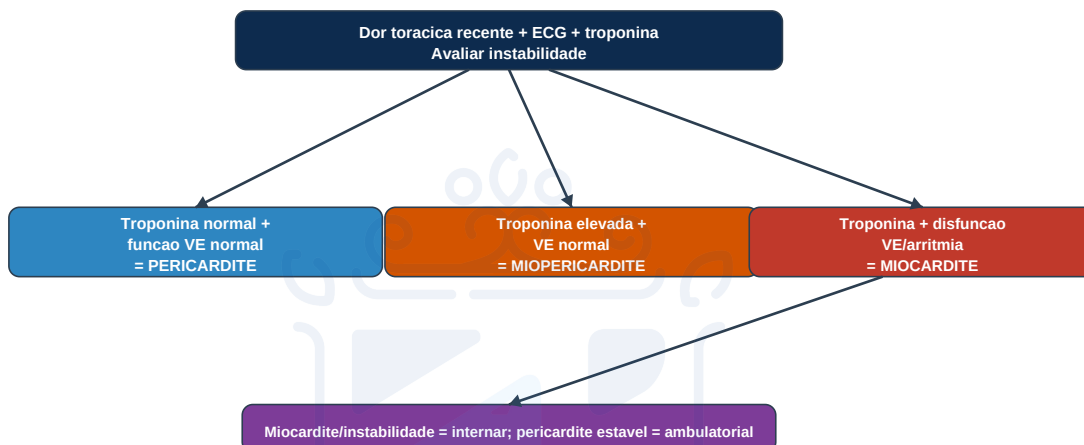


MIOCARDITE, PERICARDITE E MIOPERICARDITE

FLUXOGRAMA — DOR TORÁCICA INFLAMATÓRIA

PERICARDITE x MIOCARDITE — TROPONINA E VENTRÍCULO DECIDEM



DEFINIÇÕES

O QUE É

- Pericardite: inflamação do pericárdio (viral/idiopática); dor típica + alterações DIFUSAS no ECG
- Miocardite: inflamação do miocárdio (frequentemente viral); risco de disfunção VE, arritmias e choque cardiogênico
- Miopericardite: intermediária — pericardite + lesão miocárdica LEVE (troponina elevada) sem disfunção VE significativa
- Causas: viral (entero/adeno/influenza/SARS-CoV-2), autoimune, medicamentosa, bacteriana (rara), idiopática

QUANDO SUSPEITAR

ANAMNESE E EXAME

- Dor torácica PLEURÍTICA que melhora ao sentar e inclinar para frente (pericardite)
- História recente de infecção viral (vias aéreas/GI)
- Dispneia, palpitações ou síncope; piora aos esforços SUGERE miocardite
- Exame: atrito pericárdico (quando presente), taquicardia
- Sinais de IC, hipotensão ou choque indicam forma grave (miocardite)

DIFERENCIAÇÃO — ECG, TROPONINA E FUNÇÃO VE

Característica	Pericardite	Miocardite / Miopericardite
Dor torácica	Típica, pleurítica	Variável (mio) / típica (miopericardite)
ECG	Supra DIFUSO de ST + infra de PR	Inespecífico/arritmias (mio) ou supra difuso (miopericardite)
Troponina	Normal	Elevada (mio) / elevada leve (miopericardite)
Função ventricular	Normal	Reduzida (mio) / normal ou discreta (miopericardite)

RED FLAGS — EMERGÊNCIA CARDIOLÓGICA

MIOCARDITE COM INSTABILIDADE

- Suspeita de miocardite com instabilidade hemodinâmica é EMERGÊNCIA
- Sinais de IC aguda / edema agudo de pulmão / choque cardiogênico
- Arritmias ventriculares ou bloqueios de alto grau
- Derrame pericárdico moderado/grande -> risco de tamponamento (turgência jugular, hipotensão, bulhas abafadas)
- Febre persistente associada

AVALIAÇÃO INICIAL

CHECKLIST DE SEGURANÇA

- Dor torácica de início recente — sempre ECG IMEDIATO
- Dosar troponina (separa pericardite de mio/miopericardite)
- Avaliar instabilidade hemodinâmica e sinais de IC
- Ecocardiograma: função ventricular e derrame pericárdico
- Considerar marcadores inflamatórios (PCR/VHS) e investigação etiológica

TRATAMENTO

Rx PERICARDITE / MIOPERICARDITE

Repouso (evitar exercício até resolução)
Ibuprofeno 600mg VO 8/8h por 7-14 dias
(alt.: AAS 750-1000mg VO 8/8h)
Colchicina 0,5mg VO 12/12h (0,5mg/dia se <70kg) por 3 meses
Dipirona 1g VO/IV 6/6h se dor
Reduz recorrência: colchicina é peça-chave

Rx MIOCARDITE

Internação OBRIGATÓRIA + monitorização
Suporte hemodinâmico
Tratamento de insuficiência cardíaca
EVITAR AINEs (podem piorar a evolução)
Suporte avançado/UTI se instabilidade ou arritmia

ARMADILHA — CONTRAINDICAÇÕES

ATENÇÃO AO AINE/COLCHICINA

- NÃO usar AINE na miocardite isolada (piora a evolução)
- Contra-indicações ao AINE/colchicina: insuficiência renal moderada-grave
- Sangramento gastrointestinal ativo
- Ajustar colchicina na disfunção renal/hepática e em interações (estatinas, macrolídeos)
- Na dúvida pericardite x miocardite com troponina alta: tratar como miopericardite e internar

CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: suspeita de miocardite, troponina elevada com disfunção VE, instabilidade, derrame moderado/grande, febre persistente
- ☐ ALTA: pericardite de baixo risco, paciente estável
- ☐ ALTA: troponina normal ou discretamente elevada (miopericardite) SEM disfunção ventricular
- ☐ ALTA: seguimento cardiológico garantido + orientação de sinais de alarme
- ☐ Alarme para retorno: dispneia progressiva, síncope, palpitações, dor refratária

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com dor torácica inflamatória; hipótese: ____ (pericardite/miopericardite/miocardite).
- ECG: supra difuso/infra PR; troponina: ____; função VE ao eco: ____.
- Tratamento no PS: monitorização + analgesia/anti-inflamatório (se indicado).
- Solicito internação/avaliação cardiológica especializada (SBC/ESC) — motivo: ____.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente jovem, dor torácica que melhora ao inclinar-se para frente, ECG com supra difuso de ST e infra de PR, troponina normal e função ventricular preservada. Diagnóstico e conduta?

- A) Miocardite — internar e evitar AINE
- B) Pericardite aguda — AINE + colchicina, possível manejo ambulatorial se baixo risco
- C) IAM com supra — trombólise
- D) Dissecção de aorta — TC de aorta
- E) Embolia pulmonar — anticoagulação

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Por que se deve EVITAR AINE na miocardite isolada?

- A) Porque não tem efeito analgésico
- B) Porque pode piorar a evolução da miocardite
- C) Porque eleva falsamente a troponina
- D) Porque causa supra de ST
- E) Porque é contraindicado em qualquer dor torácica

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual medicação reduz a recorrência na pericardite aguda e deve ser associada ao anti-inflamatório?

- A) Amiodarona
- B) Colchicina
- C) Furosemida
- D) Enoxaparina
- E) Digoxina

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual achado caracteriza a MIOPERICARDITE em relação à pericardite isolada?

- A) Função ventricular gravemente reduzida
- B) Troponina elevada (lesão miocárdica leve) sem disfunção ventricular significativa
- C) Ausência de dor torácica
- D) ECG sempre normal
- E) Hemoculturas positivas

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Paciente com suspeita de miocardite e sinais de choque cardiogênico. Qual a conduta?

- A) Alta com AINE e colchicina
- B) Internação (emergência cardiológica), suporte hemodinâmico e tratamento de IC, evitando AINE
- C) Apenas analgesia oral
- D) Teste ergométrico imediato
- E) Iniciar anticoagulação plena

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Dor que melhora ao inclinar-se para frente, supra DIFUSO de ST com infra de PR, troponina normal e VE preservado = pericardite aguda. Trata-se com AINE + colchicina; casos de baixo risco e estáveis podem ser ambulatoriais.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Na miocardite isolada o AINE pode piorar a evolução (lesão miocárdica), por isso é evitado. O suporte é repouso, tratamento da IC e monitorização; AINE/colchicina ficam para o componente pericárdico.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A colchicina associada ao AINE reduz a recorrência da pericardite aguda e é recomendada por 3 meses, ajustando a dose pelo peso e função renal/hepática.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Miopericardite = pericardite + lesão miocárdica leve, com troponina elevada porém SEM disfunção ventricular significativa. Difere da miocardite (disfunção VE) e da pericardite pura (troponina normal).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Miocardite com choque cardiogênico é emergência: internação com suporte hemodinâmico e tratamento da IC, evitando AINE. Pode necessitar UTI e suporte circulatório avançado.

SM24
Suporte ao Plantão Médico